

TEMA 3.44 • OBSTETRICIA

Distocias de Presentación

PERFIL EUNACOM 1.03.44
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Distocias de Presentación

Puntos de Reparó y Vía de Parto

TABLA 3.44.1: PRESENTACIÓN VS PUNTO DE REPARO		
PRESENTACIÓN	PUNTO DE REPARO	VÍA DE PARTO
Vértice (cefálica normal)	Fontanela posterior (lambda / occipucio)	Vaginal
Bregma (cefálica deflectada leve)	Fontanela anterior (bregma)	Vaginal (más lento)
Frente	Nariz	Cesárea (más distósica — diámetro 13 cm vs. 10 cm del vértice)
Cara	Mentón	Cesárea — excepto mento-anterior/mento-púbica → vaginal
Podálica	Sacro / pies	Cesárea (en Chile, siempre)
Transversa	Acromio	Cesárea

NOTA CLÍNICA

Frente: hasta 50% cambia espontáneamente a vértice o cara en 1–2 horas → observar antes de decidir cesárea.

Cara: signo de "golpe de hacha" en Leopold (hiperextensión cervical crea espacio entre cabeza y tórax).

Podálica: riesgo principal = retención de cabeza última. Evidencia permite parto vaginal con obstetra experto, pero en Chile siempre cesárea.

Posición vs. Presentación

PERLA CLÍNICA EUNACOM

- "Posición transversa" ≠ "Presentación transversa"
- **Posición transversa** = el punto de reparo está en relación a la parte ilíaca (transversal) de la pelvis → **NO contraindica el parto vaginal**
 - **Presentación transversa** (situación transversa) = el feto está acostado → **sí contraindica el parto vaginal** → cesárea
 -

Casos Prácticos — Nombre de Posición → Diagnóstico → Vía

TABLA 3.44.2: POSICIÓN NOMBRADA VS PRESENTACIÓN		
POSICIÓN NOMBRADA	PRESENTACIÓN	VÍA
Naso-ilíaca izquierda anterior	Frente (naso = nariz)	Cesárea
Occipito-ilíaca derecha posterior	Vértice (occipucio)	Vaginal
Mento-sacra (= mento posterior)	Cara (mentón)	Cesárea (no mento-anterior)
Posición transversa ilíaca	Vértice (en posición transversa)	Vaginal
Situación transversa	Transversa	Cesárea
Bregma-púbica	Bregma	Vaginal

| Sacro-sacra | Podálica (sacro fetal) | Cesárea |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Distocias de Presentación: Chile, siempre) | | Transversa | Acromio | Cesárea | :::note Frente: hasta 50% ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Distocias de Presentación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Puntos de Reparó y Vía de Parto
- Posición vs. Presentación
- Casos Prácticos — Nombre de Posición → Diagnóstico → Vía
- (cefálica normal) | Fontanela posterior (lambda / occipucio) |
- (cefálica deflectada leve) | Fontanela anterior (bregma) |
- (más distósica — diámetro 13 cm vs. 10 cm del vértice) | |
- | Mentón | Cesárea —

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN)

PREGUNTA 1

En relación a Distocias de Presentación: Chile, siempre) | | Transversa | Acromio | Cesárea | :::note Frente: hasta 50% ... ¿cuál es la conducta correcta?

- ☐ A) El diagnóstico de Distocias de Presentación se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- ☐ B) El manejo inicial de Distocias de Presentación debe orientarse según el estado clínico del paciente
- ☐ C) Todo paciente con Distocias de Presentación requiere hospitalización inmediata
- ☐ D) El tratamiento de Distocias de Presentación es igual en todas las edades y contextos clínicos
- ☐ E) El seguimiento de Distocias de Presentación no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Distocias de Presentación?

- ☐ A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- ☐ B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- ☐ C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- ☐ D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- ☐ E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Distocias de Presentación. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- ☐ A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- ☐ B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- ☐ C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- ☐ D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- ☐ E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN

:::note Frente: hasta 50% cambia espontáneamente a vértice o cara en 1–2 horas → observar antes de decidir cesárea. Cara: signo de "golpe de hacha" en Leopold (hiperextensión cervical crea espacio entre cabeza y tórax). Podálica: riesgo principal = retención de cabeza última. Evidencia permite parto vaginal con obstetra experto, pero en Chile siempre cesárea. :::